



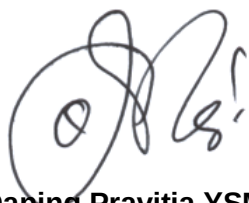
RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA
TIM PONEK
(PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF)
TAHUN 2025**

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 571.3/I-PDM/DIR/VI/2025

Tentang
Pedoman Kerja Tim Ponek

Disusun oleh :
Penanggung jawab Bab Program Nasional



(Daning Pravitia YSM, S.TR.Keb)

Di Setujui Oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr.Resti Lestanti,M.Kes)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Kerja Tim PONEK Rumah Sakit Prima Husada dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Kerja TIM PONEK (Pelayanan Obsteri Neonatal Emergency Komprehensif) ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2018. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Kerja TIM PONEK (Pelayanan Obsteri Neonatal Emergency Komprehensif) ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada

dr.Resti Lestanti,M.Kes

TIM PENYUSUN

PEDOMAN KERJA TIM PELAYANAN OBSTETRI NEONATUS ESENSIAL KOMPREHENSIF (PONEK)

1. dr. Nur Mazidah
2. dr. Aida Musyarofah, Sp. OG
3. dr. Arif Heru Wicaksono, Sp.An
4. dr. Dicky Faturrohman, Sp.A M Biomed
5. dr. Isrotul Annisa
6. dr. Annishafira
7. Daning Pravitia Y.S, S.Tr.Keb
8. Siti Zaimah Amd.Keb
9. Nining Tri Sari, Amd.Keb
10. Triasih Amd.Keb
11. Elok Oktaviana Amd.keb
12. Leny Puji rahayu Amd.Keb
13. Anita Sari S.Kep.Ns

DAFTAR ISI

Judul1

Halaman Pengesahan 2

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada 3

Kata Pengantar 6

Tim Penyusun..... 7

Daftar Isi... 8

Daftar Tabel 9

BAB I

PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Tujuan 2

 1.3 Sasaran..... 2

BAB II

TATA LAKSANA 3

BAB III

ORGANISASI TIM PONEK 7

 3.1 Pimpinan dan Staf 7

 3.2 Sarana dan FAsilitas Penunjang..... 8

 3.3 Organisasi

 3.3.1 Kriteria

 3.3.2 Tugas dan Tanggung Jawab

 3.3.3 Tentang Staf Organisasi

 3.3.4 Dukungan/kebijakan Manajemen

 3.3.5 Pengembangan dan Pendidikan

BAB IV

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 11

 4.1 Monitoring..... 11

 4.2 Evaluasi..... 11

 4.3 Laporan11

**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 571.3/I-PDM/DIR/VI/2025**

**TENTANG
PEDOMAN KERJA TIM PONEK
(PELAYANAN OBSTERI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu di Rumah Sakit Prima Husada, serta pelaksanaan rumah sakit sayang ibu dan bayi, maka perlu adanya Pedoman Kerja Tim PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif) Rumah Sakit Prima Husada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Kerja Tim PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif)
- Mengingat : 1. Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Kepmenkes Nomor HK 01017/menkes/1596/2024 tentang standart Akreditasi RS
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 938/Menkes/SK/VII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Emergency (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit
10. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

11. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PEDOMAN KERJA TIM PONEK (PELAYANAN OBSTERI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF)

BAB I

PEMBENTUKAN TIM PONEK

Pasal 1

- (1) Tim PONEK dibentuk untuk melakukan koordinasi semua kegiatan PONEK secara terstruktur yang melibatkan, staf klinis sesuai dengan ukuran, serta kompleksitas Rumah Sakit Prima Husada.
- (2) Segala yang berhubungan dengan rapat PONEK diatur oleh sekretaris Tim PONEK termasuk persiapan dan hasil rapat.
- (3) Tim PONEK membina hubungan kerja dengan Komite/Tim lain di RS yang berhubungan dengan pelayanan pasien obstetri ginekologi dan perinatologi.
- (4) Rapat Tim PONEK dilakukan rutin tiga bulan sekali.

BAB II

KINERJA TIM PELAYANAN OBSTERI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF (PONEK)

Pasal 2

- (1) Menetapkan prosedur pelayanan PONEK.
- (2) Metode pengumpulan data di unit terkait
- (3) Membuat strategi atau program pelayanan PONEK.
- (4) Proses pelaporan.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 3

Koordinasi antara Ketua Tim dengan anggota Tim PONEK dilakukan secara terstruktur dalam kegiatan pelayanan Obsteri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK) antara lain untuk menetapkan :

- (1) Mutu PONEK yang akan diukur.
- (2) Sistem pelaporan anggota Tim PONEK kepada ketua Tim PONEK yang akan dibahas di organisasi dengan melibatkan semua anggota untuk mendapatkan hasil yang akurat.

BAB IV PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 11 September 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

dr.Resti Lestanti,M.Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR : 571.2/I-PDM/DIR/VI/2025
TENTANG
PEDOMAN KERJA TIM PONEK

PEDOMAN KERJA TIM PONEK
(PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF) RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA MALANG

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang menjadi indikator kualitas kesehatan masyarakat di suatu negara, masih tergolong tinggi di Indonesia yaitu AKI: 307/100.000 KH (SDKI 2002/2003) dan AKB : 35/10000 KH (SDKI 2002/2003). Angka Kematian Ibu di Indonesia masih menempati peringkat teratas diantara negara-negara Asia Tenggara. Penyebab kematian ibu terbanyak adalah perdarahan 28%, Eklampsia 24%, Infeksi 11%, partus macet/lama 8% dan aborsi 5% (SKRT 2001).

Di dalam Angka Kematian Bayi tercakup Angka Kematian Perinatal, dimana kematian karena gangguan perinatal menurut Survey Kesehatan Rumah Tangga 1986 adalah 42,3% dari kematian bayi pada usia 0 -1 bulan. Mengingat kematian bayi khususnya dalam periode perinatal berkaitan erat dengan kesehatan ibu dimana AKI masih tinggi maka betapa pentingnya pelayanan Maternal dan Perinatal sebagai kegiatan integrative di Rumah Sakit untuk terus ditingkatkan dalam upaya menurunkan AKI dan AKB.

Penyebab kematian pada masa prenatal/neonatal pada umumnya berkaitan dengan kesehatan ibu selama kehamilan, kesehatan janin selama didalam kandungan dan proses pertolongan persalinan yang bermasalah. Komplikasi obstetric tidak selalu

dapat diramalkan sebelumnya dan mungkin saja terjadi pada ibu hamil yang diidentifikasi normal. Oleh karena itu perlu strategi penurunan kematian/kesakitan maternal perinatal dengan meningkatkan kualitas pelayanan serta kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dengan pembekalan pelatihan secara berkala.

Pedoman Kerja Tim PONEK ini merupakan pedoman untuk melaksanakan kebijakan pelayanan maternal dan perinatal di rumah sakit Prima Husada yang tercakup dalam ruang lingkup dan batasan operasional.

Tim PONEK memiliki tugas utama diantaranya sebagai berikut:

1. Mengurangi Jumlah Angka Kematian Bayi
2. Mengurangi Jumlah Angka Kematian Ibu

1.1 Tujuan

a. Tujuan Umum

Meningkatkan Pelayanan Maternal dan Perinatal yang bermutu dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia.

b. Tujuan Khusus

1. Terlaksananya manajemen pelayanan maternal dan perinatal dari aspek administrasi & manajemen, kompetensi SDM, fasilitas dan sarana serta prosedur pelayanan di RS.
2. Terklaksananya system rujukan pelayanan maternal dan perinatal.
3. Pembinaan dan pengawasan pelayanan maternal dan perinatal di RS.

1.2 Sasaran

1. Internal
Direktur, dokter spesialis Obgyn, Anak, anestesi dan umum, Tim PONEK dan tenaga kesehatan lain di Rumah Sakit Prima Husada.
2. Eksternal
Pasien dengan ibu hamil, ibu melahirkan, bayi baru lahir.

BAB II

TATA LAKSANA

Kegiatan Tim PONEK di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya merupakan suatu standar mutu pelayanan dan penting bagi pasien, petugas kesehatan maupun pengunjung rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif harus dilaksanakan oleh Tim PONEK rumah sakit dan juga fasilitas pelayanan kesehatan lainnya untuk melindungi pasien, petugas kesehatan dari kejadian tindakan yang telah dilakukan kepada pasien, yang berbasis patient safety.

A. Pelayanan Rawat Jalan

Tata Laksana pelayanan perinatal resiko tinggi dalam ruang lingkup pelayanan rawat jalan terkait dengan kegiatan terprogram dari instalasi rawat jalan yaitu dalam pelayanan di Poli Kebidanan dan Kandungan. Poliklinik Anak yang terjadwal setiap hari kerja Senin sampai dengan Sabtu jam 07.00 sampai dengan jam 13.00. Kegiatan Pelayanan Rawat Jalan adalah :

1. Poliklinik Anak
 - a. Imunisasi Layanan imunisasi di poliklinik anak meliputi program imunisasi Wajib dan imunisasi yang dianjurkan. Pelaksanaan imunisasi dilakukan setiap hari kecuali imunisasi BCG dan MR setiap hari sabtu jam 07.00 sampai dengan selesai .Selain imunisasi wajib, poliklinik anak juga melayani imunisasi lain seperti: Infarix Hexa/Hexaxim, prevenar, Rotarix, Rotatex, Typhim, Vaxigrip,MMR
 - b. Pemeriksaan rutin bayi baru lahir dan perawatan tali pusat Pemeriksaan rutin bayi baru lahir dilakukan setiap hari oleh dokter spesialis anak meliputi penimbangan berat badan, pemeriksaan kondisi umum dan fisik, pemantauan pemberian ASI dan kemampuan minum bayi. Pada saat perawatan tali pusat, dilakukan juga pemeriksaan tanda-tanda adanya infeksi tali pusat, serta edukasi mengenai cara perawatan tali pusat yang benar kepada orang tua. Dalam pemantauan pada bayi kurang bulan dilakukan pemantauan secara berkala terhadap pertumbuhan dan perkembangan apakah sudah dapat tumbuh kejar pada kronologis pertumbuhannya, komplikasi atau gangguan perkembangan yang mungkin terjadi.
2. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan.
 - a. Pelayanan pasien di poliklinik kebidanan dan kandungan dilakukan oleh

dokter spesialis kebidanan dan kandungan setiap hari kerja 08.00 sampai dengan selesai meliputi :

- Perawatan masa hamil yang meliputi kondisi kandungan. Pada kasus tertentu dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium dan USG.
- Perawatan masa nifas bagi ibu post partum, meliputi pencatatan keluhan, pemeriksaan fisik, perawatan luka episiotomi atau luka post operasi.
- Dalam pelayanan pasien di poliklinik ini dilakukan juga deteksi dini kehamilan yang mempunyai resiko tinggi serta penatalaksanaannya bahkan pencegahan komplikasi lebih lanjut dengan intervensi pengobatan yang diperlukan, dilakukan pencatatan serta perencanaan dalam proses persalinan untuk resiko tinggi

b. Pelayanan KB.

- sasaran : setiap pasangan suami istri usia produktif yang bertujuan untuk mengatur kehamilan.
- jenis pelayanan kontrasepsi : IUD, pil KB, implan atau susuk, suntik, kondom, MOW

c. Kandungan.

Pelayanan pemeriksaan wanita dengan gangguan ginekologis, misalnya mioma, kista uteri, endometriosis

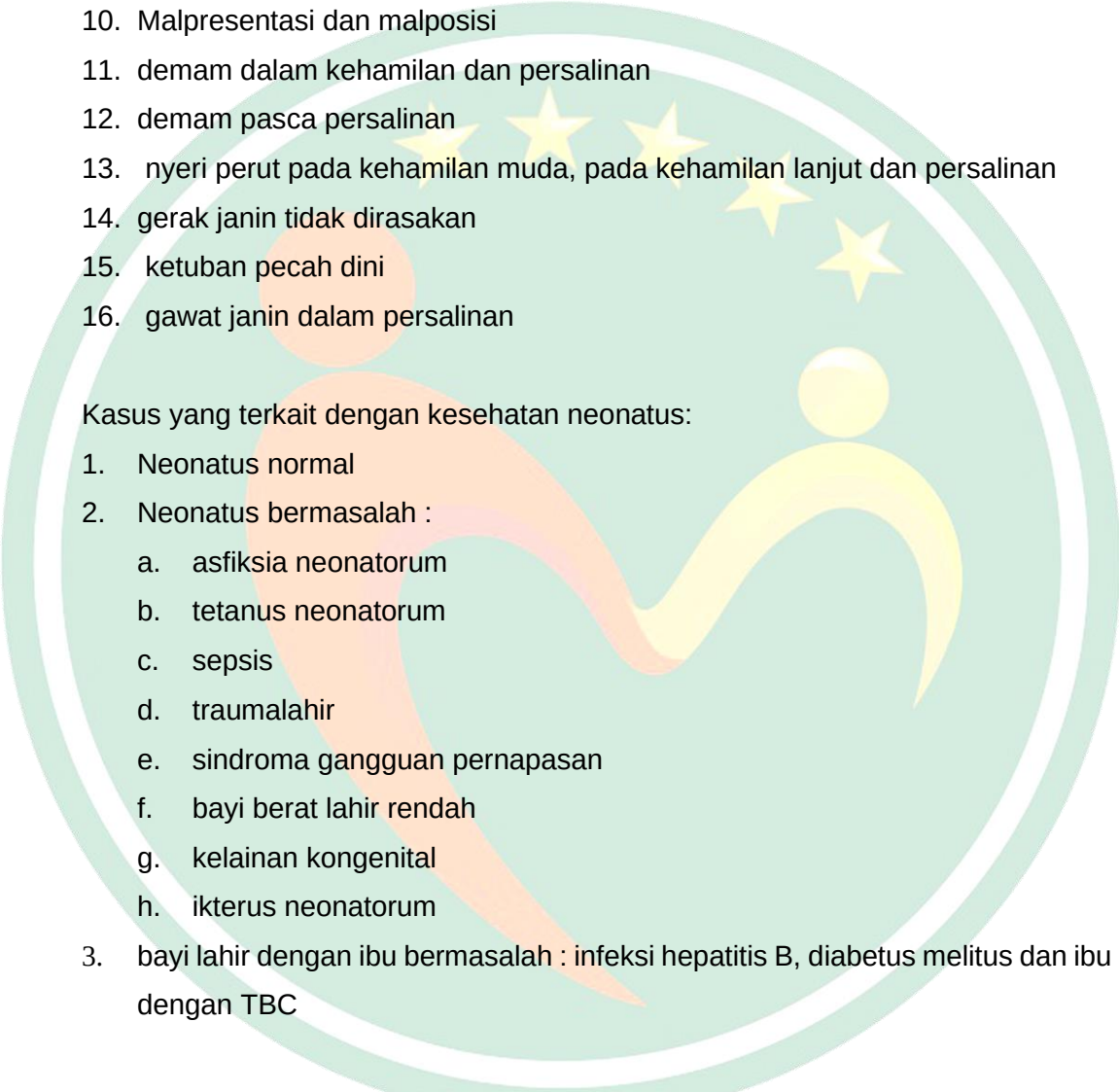
B. Pelayanan Rawat Inap.

Pelayanan rawat inap terkait secara fungsional dengan instalasi rawat inap dengan pintu masuk baik dari poliklinik maupun rawat darurat dengan kasus-kasus kehamilan patologis yang persalinan yang direncanakan maupun kasus-kasus rujukan dengan kondisi gawat darurat. Pelayanan rawat inap ada pada lantai 4C Rumah Sakit Prima Husada dengan kapasitas 13 tempat tidur, dan 6 bed tindakan, untuk neonatus yang lahir di Rumah Sakit Prima Husada terdapat 13 box bayi, 3 inkubator, 4 cuvis, 4 C-pap Mesin. Untuk neonatus kasus rujukan atau lahir di luar Rumah Sakit Prima Husada di rawat di ruang neonatus rujukan luar dengan kapasitas 2 box, 1 inkubator.

C. Klasifikasi Penyakit.

Berbagai klasifikasi kasus yang dapat menjadi bagian dalam pelayanan perinatal resiko tinggi adalah

1. Kehamilan normal
2. Pelayanan Kesehatan Maternal dengan masalah yaitu:

- 
3. Syok
 4. Perdarahan pada kehamilan muda
 5. Perdarahan pada kehamilan lanjut dan persalinan
 6. Perdarahan pasca persalinan
 7. Nyeri kepala, gangguan penglihatan, kejang dan atau koma
 8. Tekanan darah tinggi
 9. Persalinan lama
 10. Malpresentasi dan malposisi
 11. demam dalam kehamilan dan persalinan
 12. demam pasca persalinan
 13. nyeri perut pada kehamilan muda, pada kehamilan lanjut dan persalinan
 14. gerak janin tidak dirasakan
 15. ketuban pecah dini
 16. gawat janin dalam persalinan

Kasus yang terkait dengan kesehatan neonatus:

1. Neonatus normal
2. Neonatus bermasalah :
 - a. asfiksia neonatorum
 - b. tetanus neonatorum
 - c. sepsis
 - d. traumalahir
 - e. sindroma gangguan pernapasan
 - f. bayi berat lahir rendah
 - g. kelainan kongenital
 - h. ikterus neonatorum
3. bayi lahir dengan ibu bermasalah : infeksi hepatitis B, diabetes melitus dan ibu dengan TBC

D. Penyelesaian dan pengembalian Rekam Medis

Data Rekam Medis yang berkaitan dengan pelayanan perinatal resiko tinggi disesuaikan dengan segala persyaratan dan ketentuan dari instalasi rekam medis baik dalam hal pengisian, waktu penyelesaian kelengkapan serta pengembalian data. Pengisian rekam medis sesuai dengan ketentuan rekam medis dan pengembalian rekam medis 1 x 24 jam.

E. Sistem Rujukan.

1. Pengertian Rujukan

Sistem Rujukan merupakan penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik vertikal maupun horizontal, maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan. Kegiatan rujukan mencakup:

a. Rujukan Pasien

- Rujukan pasien internal adalah rujukan antar spesialis dalam satu rumah sakit.
- Rujukan eksternal adalah rujukan antar spesialis keluar rumah sakit dengan mengikuti sistem rujukan yang ada

b. Rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk peningkatan kemampuan tenaga kesehatan (dana, alat dan sarana).

c. Rujukan Manajemen

Dapat berupa permintaan kepada unit yang lebih mampu atau bantuan kepada unit yang kurang mampu untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu yang tidak dapat diatasi sendiri.

1. Sistem pelayanan rujukan maternal dan perinatal di rumah sakit Prima Husada

Bila pasien maternal dan perinatal tidak dapat ditangani sendiri segera rujuk ke sarana kesehatan yang lebih lengkap fasilitas dan tenaga kesehatannya. Harus ada koordinasi, mudah sehingga tidak merugikan pasien. Mudah, cepat dan tepat adalah yang utama. Rujukan internal rumah sakit berpedoman kepada prosedur rujukan di dalam rumah sakit dan mekanisme kerja di bagian /instalasi Anak, Obstetri, dan Ginekologi. Rujukan eksternal mengikuti mekanisme rujukan sesuai jenjang pelayanan. Persiapan Rujukan Pasien ke jenjang pelayanan yang lebih tinggi:

- a. Menyiapkan petugas yang terlatih untuk mendampingi pasien
- b. Memberi penjelasan kepada pihak keluarga alasan pasien di rujuk ke rumah sakit lain.
- c. Memberi penjelasan kepada pasien dan keluarganya
- d. bahwa segala tindakan yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayinya.
- e. Pada saat merujuk pasien harus disertakan surat rujukan dan resume medik pasien meliputi: riwayat penyakit, penilaian kondisi pasien yang dibuat saat kasus diterima perujuk, tindakan atau pengobatan yang telah

diberikan dan keterangan lain yang perlu atau ditemukan sehubungan dengan kondisi pasien. Proses pelaksanaan rujukan harus mendapat persetujuan dari dokter dan keluarga

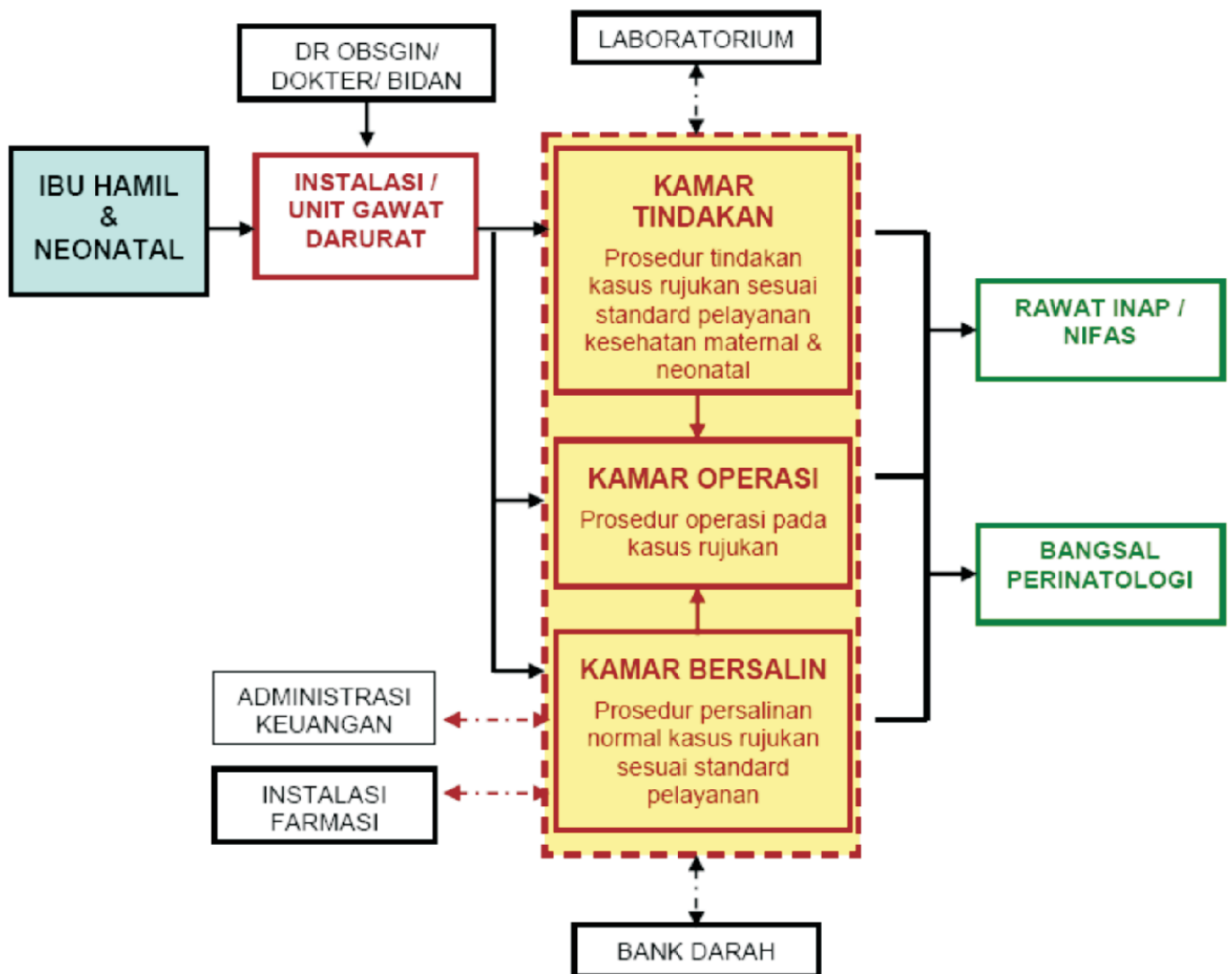
f. Rumah Sakit sebagai penerima rujukan:

Memberi penjelasan kepada pasien dan keluarganya bahwa segala tindakan yang dilakukan adalah untuk menyelamatkan ibu dan bayinya.

g. Persiapan pihak keluarga untuk memberikan darah jika dibutuhkan
Pasien/keluarga diberi penjelasan mengenai tindakan/perawatan yang akan dilaksanakan.



2. Alur Pasien PONEK Maternal dan Neonatal



BAB III

ORGANISASI TIM PONEK

(PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENCY KOMPREHENSIF)

Organisasi PONEK disusun agar dapat mencapai visi, misi, dan tujuan dari penyelenggaraan PONEK. PONEK dibentuk berdasarkan organisasi yang miskin struktur dan kaya fungsi dan dapat menyelenggarakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara efektif dan efisien. Efektif dimaksud agar sumber daya yang ada di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

3.1 PIMPINAN DAN STAF

Pimpinan dan petugas kesehatan dalam Tim PONEK diberi kewenangan dalam menjalankan program di rumah sakit.

Kriteria:

1. Tim PONEK minimal disusun terdiri dari :

- 1 dokter Spesialis Kebidanan Kandungan
- 1 dokter spesialis anak
- 1 dokter di Unit Gawat Darurat
- 3 orang bidan (1 koordinator dan 2 pelaksana)
- 2 orang perawat

Tim PONEK Ideal ditambah :

- 1 Dokter spesialis anesthesi / perawat anesthesi
- 6 Bidan pelaksana
- 10 Perawat (tiap shift 2-3 perawat jaga)
- 1 Petugas laboratorium
- 1 pekaya kesehatan
- 1 Petugas administrasi

Ketua sebaiknya dokter, mempunyai minat, kepedulian dan pengetahuan, pengalaman, mendalami masalah kegawatdaruratan PONEK. Sekretaris sebaiknya bidan, yang disegani, berminat, mampu memimpin, dan aktif.

Anggota yang terdiri dari:

- a. Dokter Umum IGD
- b. Bidan ruangan maternitas
- c. Perawat/Bidan perinatologi
- d. Perawat IGD

- e. Perawat Anestesi
- f. Perawat ICU
2. Anggota Tim PONEK terdiri dari 5 orang bidan, 2 orang perawat.
3. Dalam bekerja Tim PONEK dapat kolaborasi dengan unit pelayanan lain.



1. DIREKTUR RUMAH SAKIT

Tugas Direktur Rumah Sakit

1. Membentuk Tim PONEK dengan Surat Keputusan
2. Bertanggung jawab dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelenggaraan pelayanan PONEK.
3. Bertanggung jawab terhadap tersedianya fasilitas sarana dan prasarana termasuk anggaran yang dibutuhkan
4. Menentukan kebijakan pelayanan PONEK.
5. Mengadakan evaluasi kebijakan pelayanan PONEK berdasarkan saran dari Tim PONEK RS
6. Mengesahkan Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk pelayanan PONEK RS

2. TIM PONEK

A. Kriteria Anggota Tim PONEK

1. Mempunyai minat dalam PONEK
2. Pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan PONEK

B. Uraian Tugas

Tim PONEK mempunyai tugas sebagai berikut:

1. sebagai motor penggerak penyusunan program PONEK rumah sakit;
2. melakukan monitoring dan memandu penerapan program PONEK di unit kerja.
3. menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait serta menyampaikan masalah terkait pelaksanaan program PONEK.
4. terlibat secara penuh dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan PONEK.
5. bertanggung jawab untuk mengomunikasikan masalah-masalah PONEK secara rutin kepada ketua PONEK dan direktur Rumah Sakit.
6. menyusun regulasi terkait penerapan program PONEK.

C. Uraian Jabatan

1. Ketua Dan Wakil Tim Ponek

a. Syarat Jabatan

- 1) Pendidikan dasar dokter spesialis kandungan dan kebidanan.
- 2) Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidangnya.
- 3) Memiliki dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi.
- 4) Memiliki kemampuan kepemimpinan.

b. Wewenang

- 1) Mendelegasikan tugas apabila berhalangan hadir.
- 2) Memeriksa hasil kegiatan PONEK.

c. Tanggung jawab

- 1) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan visi dan misi PONEK.
- 2) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan evaluasi.
- 3) Bertanggung jawab terhadap Direktur.

d. Uraian Tugas

- a. Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu profesi pelayanan.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang keperawatan maupun kepala instalasi yang terkait dalam membina kualitas profesi pelayanan.
- c. Mengendalikan dan mengevaluasi kualitas pelayanan profesi.

e. HasilKerja

Terselenggaranya visi, misi, dan program PONEK di rumah sakit secara menyeluruh dan terpadu.

2. Sekretaris Tim Ponek

a) Syarat Jabatan

- 1) Pendidikan DIII/Sederajat
- 2) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang PONEK
- 3) Telah mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidangnya.

b) Uraian Tugas

- 1) Membuat undangan rapat dan membuatnotulen.
- 2) Mengelola administrasi surat-suratPONEK.
- 3) Mencatat data-data yang berhubungan denganPONEK.
- 4) Mencatat data-data yang berhubungan denganPONEK.
- 5) Memberikan bantuan-bantuan yang diperlukan oleh penanggungjawab dan penanggung jawab sosialisasi dari suksesnya programPONEK.
- 6) Melakukan tugas-tugas lain dari atasan yang berhubungan dengan PONEK.

c) HasilKerja

- 1) Terkelola dan terdokumentasinya seluruh data PONEK.
- 2) Terkoordinasinya seluruh pelayanan program kegiatan PONEK.

3. Anggota Tim Ponek

a. IGD

1. Syarat Jabatan

- a) PendidikanDIII/S1 kebidanan/keperawatan
- b) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang kegawat daruratan PONEK.

2. TanggungJawab

- a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaanpelayanan program.
- b) Bertanggung jawab kepada ketua timPONEK

3. UraianTugas

- a) Melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan maternal danneonatal.
- b) Melakukan koordinasi dengan ketua tim PONEK dan tim medislain.

- c) Melaksanakan evaluasi terhadap kasus-kasus kegawatdaruratan obstetric dan neonatal.

4. Hasil kerja

Terselenggaranya semua pelayanan kegawatdaruratan PONEK di Instalasi Gawat Darurat

b. Poli Obgyn dan Poli Anak

1. SyaratJabatan

- a) Pendidikan dasar DIII Kebidanan.
- b) Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait obstetric dan ginekologi

2. UraianTugas

- a) Melaksanakan pelayanan antenatal care (ANC), post natal Care (PNC), program imunisasi, program keluarga berencana, pelaksanaanTumbuhkembangbayi, balitadananak..
- b) Pemantauan pelaporan pelayananPONEK.
- c) Melakukan koordinasi dengan ketua tim PONEK terkait dengan pelayanan PONEK.

3. HasilKerja

Terselenggaranya semua pelayanan PONEK di Poli Obgyn dan Poli Anak

c. Ruang Bersalin & Nifas

1. SyaratJabatan

- a) DIII Kebidanan dan DIV Kebidanan
- b) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentangPONEK
- c) Pernah mengikutipelatihan-pelatihan

2. TanggungJawab

- a) Bertanggung jawab terhadap ketua timPONEK
- b) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program di masing-masing unitkerjanya.

3. UraianTugas

- a) Membuat perencanaan untuk pelayanan di ruang bersalin dan pelayanan nifas
- b) Melakukan kegiatan-kegiatan operasional untuk pelayanan persalinan dan nifas (pengawasan dan perawatan nifas, IMD, menyusui, perawatan payudara, rawatgabung, PMK pada bayi

berat badan rendah, Pemberian ASI Eksklusif).

- c) Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan tim pelayanan perinatal dalam rangka kegiatan operasional
- d) Melakukan pengawasan kegiatan di ruang bersalin dan ruang nifas.
- e) Melakukan pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
- f) Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan PONEK termasuk pencatatan dan pelaporan.

4. Hasil kerja

Terselenggaranya semua program pelayanan PONEK di ruang bersalin

d. Pelayanan Perinatologi

1. Syarat Jabatan

- a) DIII Kebidanan atau Keperawatan.
- b) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang kegawatdaruratan PONEK
- c) Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan NICU/PICU/ Kegawatdaruratan Neonatal

2. Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program di ruang perinatologi.
- b) Bertanggung jawab terhadap ketua tim PONEK.

3. Uraian Tugas

- a) Membuat perencanaan untuk pelayanan perinatologi.
- b) Mengawasi dan melakukan kegiatan-kegiatan PONEK di ruang perinatologi seperti Pelayanan Metode Kangguru Pada Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah, IMD di ruang bersalin dan ruang recovery room (RR), Rawat Gabung Ibu dan bayi, Pemberian ASI Eksklusif.
- c) Melakukan koordinasi dengan tim pelayanan ruang bersalin dan nifas dalam rangka kegiatan operasional.
- d) Pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
- e) Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan perinatologi termasuk pencatatan dan pelaporan

4. Hasil Kerja

Terselenggaranya semua program pelayanan PONEK di ruang

perinatologi.

e. Pelayanan ICU

1. Syarat Jabatan

- a) S1 Keperawatan.
- b) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang kegawatdaruratan PONEK
- c) Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan kegawatdaruratan ICU

2. Tanggung Jawab

- c) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan program di masing-masing unit kerjanya
- d) Bertanggung jawab terhadap ketua tim PONEK.

3. Uraian Tugas

- a) Membuat perencanaan untuk pelayanan pasien di ICU.
- b) Mengawasi kegiatan-kegiatan PONEK di ruang ICU.
- c) Melakukan koordinasi dengan tim pelayanan ruang bersalin dan nifas dalam rangka kegiatan operasional.
- d) Pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
- e) Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan PONEK di ICU termasuk pencatatan dan pelaporan

4. Hasil Kerja

Terselenggaranya semua pelayanan PONEK di ruang ICU.

f. Pelayanan Kamar Operasi

1. Syarat Jabatan

- a) S1 Keperawatan.
- b) Memiliki ketrampilan dan pengetahuan tentang kegawatdaruratan PONEK
- c) Pernah mengikuti pelatihan-pelatihan tentang penanganan kegawatdaruratan PONEK

2. Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pelayanan program PONEK di instalasi IKO
- b) Bertanggung jawab terhadap ketua tim PONEK.

3. Uraian Tugas

- a) Membuat perencanaan untuk pelayanan pasien kegawatdaruratan obstetric neonatal di ruang kamar Operasi

- b) Mengawasi kegiatan-kegiatan pelayanan di ruang kamar Operasi terkait pelayanan PONEK.
 - c) Melakukan koordinasi dengan tim pelayanan ruang bersalin dan nifas dalam rangka kegiatan operasional, seperti Inisiasi Menyusu Dini (IMD) yang dilakukan di kamar operasi.
 - d) Pengawasan terhadap SPO yang telah ditetapkan.
 - e) Melakukan evaluasi kegiatan operasional dan mutu pelayanan kegawat daruratan obstetric dan ginekologi di ruang operasi termasuk pencatatan dan pelaporan
4. Hasil Kerja
- Terselenggaranya semua program pelayanan PONEK di instalasi kamar operasi.

1.2 SARANA DAN FASILITAS PELAYANAN PENUNJANG (SUPPORTING SYSTEM)

1. Sarana Kesekretariatan

- a. Tersedianya ruangan meeting
- b. Komputer, printer, dan internet.
- c. Telepon
- d. Alat tulis kantor.

2. Dukungan Manajemen

Dukungan yang diberikan oleh manajemen berupa:

- a. Penerbitan Surat Keputusan untuk Tim PONEK RS
- b. Anggaran atau dana untuk kegiatan :
 - 1) Pendidikan atau Pelatihan (diklat)
 - 2) Pengadaan fasilitas pelayanan penunjang.
 - 3) Untuk pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, laporan, dan rapat rutin.
 - 4) Intensif/Tunjangan/Reward untuk Tim PONEK RS

3. Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional

Kebijakan dan Standar Prosedur Operasional yang perlu dipersiapkan oleh rumah sakit adalah:

- 1. Kebijakan Manajemen
 - a. Adanya kebijakan tentang pengembangan SDM dalam PONEK.

- b. Adanya kebijakan tentang pengadaan bahan dan alat yang melibatkan tim PONEK.
- c. Adanya kebijakan tentang pemeliharaan fisik dan sarana yang melibatkan tim PONEK.

2. Kebijakan Teknis

Ada SPO tentang kewaspadaan isolasi (*isolation precaution*):

- a. Ada SPO Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
- b. Ada SPO Rawat Gabung Ibu dan Bayi
- c. Ada SPO Perawatan Metode Kangguru Pada Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (PMK pada BBLR)
- d. Ada SPO Tata Cara Menyusui Bayi
- e. Ada SPO Perawatan Payudara
- f. Ada SPO Persalinan Normal
- g. Ada SPO Menjemur Bayi
- h. Ada SPO Perawatan Tali pusat.

4. Pengembangan dan Pendidikan

- a. Wajib memiliki pendidikan dan pelatihan PONEK
- b. Memiliki sertifikat PONEK
- c. Mengembangkan diri mengikuti seminar, lokakarya, dan sejenisnya.
- d. Bimbingan teknis secara berkesinambungan

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1 Monitoring

Monitoring dilakukan oleh seluruh anggota Tim PONEK

4.2 Evaluasi

Rapat Evaluasi dilakukan oleh Tim PONEK minimal setiap 3 bulan sekali.

4.3 Laporan

Membuat laporan tertulis 3 bulan sekali yang ditujukan kepada Direktur RS.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 11 September 2025
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Resti Lestanti, M. Kes